

乙胺碘呋酮的不良反应及药物相互作用

保定地区医院 王安梅 刘 辰 张国存

乙胺碘呋酮(Amiodarone 简称AIR)为苯并呋喃衍生物,是抗心律失常药中安全范围大且作用持续时间长的药物。由于这些优点,临床上滥用现象日趋严重,以致引起了一些不良反应,甚至导致死亡。现将不良反应和药物相互作用阐述如下,以供参考。

不良反应

一、消化系统[1][2][3]

服用AIR可发生恶心、呕吐、便秘、口干、腹胀、食欲不振等胃肠道症状,偶见顽固性呃逆。有报道AIR致黄疸2例。另有报道在使用AIR治疗心律失常的341例中,出现胃肠道反应者55例,约占16%。空腹服药及原有消化系统疾病者反应多见;而静脉给药者胃肠道反应少见。这可能与AIR直接刺激胃粘膜有关。

另有报告用AIR后对肝脏出现毒性作用:单项高转氨酶血症在用药后不久发生,约占用药者的11~55%。皆为轻度肝功改变;谷草转氨酶和(或)谷丙转氨酶升高;极少数碱性磷酸酶(AKP)升高。这与用药剂量大有关。减少剂量或停药,生化改变可恢复正常。7例在用AIR 5个月至3年后发生慢性肝病。特点为类似酒精性肝炎的组织改变。表现为不同程度的脂肪变性、Mallory小体和嗜中性多核白细胞浸润。伴硬化者4例,中或重度肝纤维化者3例。患者症状很少而组织学异常已很明显,临床表现仅限于肝大,SGOT较SGPT高。

二、甲状腺[2][4][5]

AIR每分子含二个碘原子,每天服400mg相当于元素碘188.8mg或芦戈氏碘液24滴。因此可引起甲状腺功能紊乱。其发生率约为8.9~14.3%。AIR可抑制周围 T_4 转

变为 T_3 ,却增加了转变为反 T_3 (rT_3)的可能。其结果使血浆 T_4 、 rT_3 水平升高及 T_3 水平下降。血中 T_4 增高还可能与AIR含碘量较高有关。Marcus等认为AIR并发甲状腺机能亢进的危险性可能比所认识的更严重。Harris等检测85例长期服用AIR患者 T_4 ,平均水平高于正常人均值的20%以上。5例 T_4 降低,促甲状腺激素(TSH)增加,其中2例出现粘液性水肿。4例 T_4 升高25%以上,其中2例出现临床甲状腺机能亢进。

三、心血管[2][4][6]

应用AIR过程中可出现持续性心动过缓、窦性骤停、窦房传导阻滞、P—R间期延长和Ⅱ度房室传导阻滞,也可引起Q—T间期明显延长,T波低并出现切迹和U波明显等。Mcgooven报道80例应用AIR患者中12例(15%)有潜在的致命性反应,其中3例(4%)发生窦性停搏伴逸搏点抑制。另有报道应用AIR20例中,12例(60%)出现窦性心动过缓,1例(5%)出现Ⅱ度I型房室传导阻滞。上海用AIR222例,结果有34例(15.3%)窦房结和房室结功能受到影响。

祝雄报道使用AIR52例,死亡4例(7.7%),其中1例服用AIR4次后出现反复室性心动过速而死亡;1例服用AIR9小时后发生阿斯氏综合征,总量0.6g;1例服药3天后死亡,总量1.6g,血 K^+ 正常,QT波正常;1例与地戈辛联用,5天后发生室扑、室颤而死,总量1.8g。

此外,法国心脏病学会报道11例静脉注射而产生严重副作用,5例死亡。这主要是由于在15分钟内重复注射用药。Fogoros报道致死病例都可能与剂量大(10mg/kg),

造成心肌抑制有关。

四、肺脏[2][4][6][7]

一般认为可能是对AIR过敏所致,也可能是对肺脏的直接损害。临床表现多在治疗后出现肺内浸润性改变、咳嗽及呼吸困难,肺功能多显示低下,并存在低氧血症,肺活检可见到纤维化引起的肺泡壁增厚,还可见到中性白细胞、淋巴细胞的渗出。其发生率约为6.6%。引起肺损害多发生在口服600~800mg/天的治疗中。肺浸润多出现在用药后3~14个月,最长可达28个月。尽管停药后肺浸润可逐渐减轻,但欠理想,预后不佳,甚至可致死。

Akoun G 等报道,AIR引起肺部病变发生率为1.4~20%。15例见于成人,口服200~1000mg/天。

Olson L K 报道34例中6例(17.6%) 在1.5~2个月内发生肺炎。常见咳嗽、发热、呼吸困难。

Harris 等报道的140例中1例发生肺功能限制型的肺间质改变,4例作活检,仅有非特异性的肺泡壁纤维化和不典型肺细胞。

卢德新报道有1例服AIR 7天后出现过敏性哮喘。

五、眼[2][14]

最常见的副作用是角膜出现微小沉淀。其发生率约为14.8~20.8%。表现为角膜内特殊的黄棕色素沉着。电镜检查在角膜基底细胞和基质细胞浆中可见到大量的脂褐色的溶酶体包涵物。其原因可能与碘从睑板腺排出有关。一般不影响视力,微小沉淀在停药后即可消失。间歇停药或用1%甲基纤维素或碘碘肝素滴眼可减轻或预防这种沉淀。

六、神经系统[4][8][9]

神经系统副作用一般较少发生。可致震颤、共济失调和周围神经病变。Heger 等45例中2例出现神经系统副作用(4.4%),表现为肢体近端无力、步态异常震颤、位觉和

神经传导异常等。陈协青等报告AIR致精神失常1例。姜彦德报告引起肢体震颤、共济失调1例,其发生和消失与AIR的半衰期($t_{1/2}$)有关,此症多为可逆性,停药后不需要特殊处理即可自然消失。

七、皮肤[4][6]

皮肤反应有两类:一类是碘引起的过敏性皮炎,另一类是皮肤光照过敏性皮疹。前者常发生在首次治疗的碘过敏者,后者则多发生在大剂量和长期治疗的过程中,57%有光敏反应。AIR有对光敏感性增强引起晒伤的副作用和症状光敏性皮炎,偶见皮疹、红斑及前臂皮肤色素沉着。AIR使皮肤对日光的刺激产生过敏反应的机制是通过抗VitB₆的效应,减少皮肤中Vit B₆的浓度,致使AIR抑制了皮肤中黑色素的形成。经过几个月的潜伏期后,使皮肤对阳光的刺激产生过敏反应。

八、其它副作用[2][4][6][10][11]

有失眠、头昏、头痛、视力模糊、多梦、眼眶痛等神经症状。也有血凝障碍和骨髓抑制、性功能减退、月经失调、脱发、高Ca²⁺血症、肾功能衰竭等。还可以引起耳聋、口吃。

药物相互作用[12-16]

一、抗凝血药

AIR可以增强双香豆素、华法令的抗凝作用,亦影响肝素的活性。对凝血酶原活性的影响与剂量无关。AIR与华法令联用时,华法令剂量应减少1/3~1/2。

二、地戈辛

使用AIR 24小时后,地戈辛的血清浓度上升。在6~7天内直线上升,随后稳定在高水平。其相互作用与剂量有关,而且与AIR的浓度一致。减半地戈辛剂量后,血和尿地戈辛浓度下降,但与剂量减少后所应有的下降相比,仍有相对增长。目前对并用AIR后地戈辛浓度增高的机制有不同看法,

有人认为是AIR将组织中的地戈辛置换出来影响其排泄；也有人认为可能与肾小管排泄地戈辛的作用减弱有关。AIR降低地戈辛的总体清除率（从0.76降至0.64ml/min·kg）和非肾清除率（从0.46降至0.30ml/min·kg），使地戈辛的半衰期（ $t_{1/2}$ ）延长（由49.5延长至65小时），表观分布容积减少（由7.88降至7.02L/kg）。在使用AIR时，地戈辛的血清浓度通常加倍。

三、其他抗心律失常药

AIR可以提高奎尼丁的血清浓度，使奎尼丁用药后QT间期延长。AIR同时还可以增强茚丙胺、普鲁卡因胺、心律平、双异丙吡胺、慢心律、室安卡因等药物的作用及副作用。使用AIR后，另一种抗心律失常药的用量可减少50%。AIR与 β -受体阻滞剂和钙离子拮抗剂，如异搏定、硫氮草酮等联用时，可使窦性心律减慢加强，严重者可出现窦性骤停、房室阻滞。

AIR与利多卡因联用可致窦性骤停。与全身麻醉药联用可出现低血压、房室阻滞。

参 考 文 献

- [1]佟成文，等。乙胺碘呋酮所致黄疸2例。中华心血管病杂志 1986；14（5）：304
- [2]余文光。乙胺碘呋酮的不良反应及预防。中国医学杂志 1985；5（5）：211
- [3]何利平译。乙胺碘呋酮的肝脏毒性作用。国外医学 消化系统疾病分册 1986；3：171
- [4]谭湘明。乙胺碘呋酮的临床副作用。实用内科杂志 1985；5（5）：260
- [5]张程立。乙胺碘呋酮对甲状腺的毒副作用反应。中国医院药杂志 1987；7（9）：369
- [6]祝雄。乙胺碘呋酮在临床应用中的副作用。中国医院药杂志 1986；6（2）：63
- [7]卢德新。乙胺碘呋酮致过敏性哮喘1例。中华心血管病杂志 1985；13（1）：31
- [8]陈协青，等。乙胺碘呋酮致精神失常1例。中华心血管病杂志 1986；14（5）：273
- [9]姜彦得。乙胺碘呋酮引起肢体震颤共济失调1例。中国医院药杂志 1987；7（1）：422
- [10]路云飞。乙胺碘呋酮引起耳聋1例。中华内科杂志 1986；25（9）：558
- [11]赵立辅，等。乙胺碘呋酮引起口吃1例。中华心血管病杂志 1986；（14）：42。
- [12]孙忠实。乙胺碘呋酮与其他药物的相互作用。中国医院药杂志 1985；5（7）：299
- [13]杨俊何。乙胺碘呋酮与其他药物的相互作用。医师进修杂志 1985；9：39
- [14]张宝恒，等。乙胺碘呋酮临床药理学研究进展。临床医学杂志 1986；2（6）：371
- [15]徐美娟，等。地戈辛与乙胺碘呋酮相互作用的临床观察。中国医院药杂志 1987；7（2）：68

硫酸庆大霉素不宜用作感冒药

中国人民解放军二五二医院 刘新民

感冒是一种最为常见的病毒性感染疾病。硫酸庆大霉素是一种氨基甙类广谱抗菌素，主要用于葡萄球菌、大肠杆菌等引起的细菌性感染疾病，没有抗病毒作用。我们在工作实践中发现，以硫酸庆大霉素作为感冒首选药或与其它感冒药合用的现象屡见不鲜，尤其是基层医院或诊所更为多见。这样的治疗方法是一种缺乏科学根据的滥用药现象。

当然，如果感冒合并上呼吸道感染等其它细菌性感染疾病，也是可以伍用的。但是，那种不根据病情滥用硫酸庆大霉素将会给病人带来许多副作用：对颅神经和肾脏的损害，出现眩晕、耳鸣、四肢及头皮发麻，严重时可引起蛋白尿、管型尿，尿中出现红、白细胞，以致过敏性休克。应当引起注意。